



PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PERIODONTAL

Clínica Universitaria de Odontología

El protocolo de mantenimiento periodontal (también llamado *terapia de soporte periodontal*, TSP) es fundamental para **prevenir la recurrencia de la periodontitis** y mantener los resultados a largo plazo. Se aplica una vez que el paciente ha pasado por la fase activa del tratamiento (es decir, la fase etiológica y quirúrgica si fue necesaria).

OBJETIVOS:

1. **Reevaluar** la situación periodontal del paciente en el momento.
2. **Instrucción** sobre higiene y re-motivación sobre el problema.
3. **Intervenir** para corregir las zonas de actividad de la enfermedad.

1.- REEVALUACIÓN

A. Recepción del paciente

Realizaremos una verificación de la situación afectiva del paciente sobre su problema y su relación con nosotros. Actualizaremos su historia médica. Comprobaremos si ha surgido algún elemento distractor como sensibilidad, hemorragia, dolor, etc.

B. Determinación y registro de los indicadores periodontales

- Profundidad de sondaje periodontal sondando con más interés las bolsas:
 - Que tenían antes del tratamiento más de 5 mm.
 - Que en la revisión anterior habían mostrado aumento de más de 2 mm de profundidad.
 - Con hemorragia persistente.

Nota: Se anotarán en el periodontograma sólo las profundidades de sondaje iguales o superiores a 4 mm.

- Índice de hemorragia al sondaje

- Recesión gingival: Se valorarán las zonas con falta de encía insertada y las que hayan recibido tratamiento mucogingival.

- Movilidad: Se deberá compararla con los registros anteriores.

Nota: Prestar especial interés a la de los dientes que puedan ser o son pilares de puentes, o los que tengan una situación oclusal compleja.

2.- INSTRUCCIÓN

A. Re-motivación del paciente

Haremos un recordatorio de los conocimientos del paciente sobre su enfermedad. En este momento le mostraremos al paciente la evolución de los registros obtenidos de su boca (placa, hemorragia, bolsas, radiografías), y con el espejo en la mano le enseñamos en su propia boca los aspectos más destacables. También es bueno dar información al paciente sobre avances en el conocimiento de las enfermedades periodontales, como por ejemplo su relación con otras enfermedades sistémicas.

B. Instrucción de higiene

Refuerzo del hábito de higiene y de la técnica de realización. Hemos de tener en cuenta que suele haber una recaída con el paso del tiempo. Por ello suele ser interesante el mostrarle al paciente el registro de placa obtenido.

3.- INTERVENCIÓN

Será la parte del mantenimiento periodontal a la que dediquemos el mayor tiempo, aproximadamente la mitad del tiempo total.

Fases:

1. Tartrectomía

La mayor parte de los pacientes presentan un cierto acúmulo de cálculo supragingival, sobre todo en la zona lingual del sextante 5. Este cálculo es blando todavía y está poco adherido al diente por lo que se elimina bien con ultrasonido.

2. Raspado y alisado radicular

Es difícil que se haya acumulado cálculo subgingival bien estructurado en los 4 o 6 meses transcurridos desde el último mantenimiento, por lo que se trata de alisar raíces que empiezan a estar algo rugosas. Para ello trabajaremos con curetas muy bien afiladas. Con la sonda iremos detectando las "áreas problema" y las iremos alisando. Siempre deberemos alisar las zonas con hemorragia, aunque parezca que están lisas, sobre todo si en registros anteriores ya habían mostrado sangrado.

3. Pulido y cubetas de flúor o gel de clorhexidina

El pulido nos permite crear una superficie supragingival muy lisa. Como las bacterias periodontopatógenas se adhieren mal a las superficies lisas, éste es el mecanismo de control de la periodontitis, y se olvida con frecuencia. El pulido debe hacerse con copas de goma especiales y pasta abrasiva a baja velocidad.

Para finalizar aplicación de cubetas de flúor para prevenir caries, sobre todo las radiculares en las zonas de recesión gingival, y disminuir la sensibilidad dentinaria o cubetas de gel de clorhexidina para facilitar la cicatrización del tratamiento realizado.

MANTENIMIENTO PERIODONTAL



Figura 1: Esquema del Mantenimiento periodontontal

FRECUENCIA DE VISITAS

Se determina según el **riesgo individual del paciente**:

Riesgo	Frecuencia recomendada
<i>Bajo</i>	Cada 6-12 meses
<i>Medio</i>	Cada 4-6 meses
<i>Alto</i>	Cada 3 meses

FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO:

- Mala higiene oral
- Sangrado al sondaje
- Bolsas residuales >5 mm
- Tabaquismo
- Diabetes
- Antecedentes de periodontitis severa
- Pérdida ósea avanzada
- Pacientes portadores de implantes

CRITERIOS DE ÉXITO DEL MANTENIMIENTO

- Ausencia de sangrado al sondaje o mínima presencia.
- Bolsas ≤ 4 mm sin sangrado.
- Buen control de placa.
- Ausencia de movilidad progresiva o pérdida de inserción.

PATOLOGÍA PERIIMPLANTARIA

La prevención de la patología periimplantaria deberá realizarse a dos niveles:

- Controlar o eliminar los factores de riesgo de aparición de patología periimplantaria.
- Monitorización para el diagnóstico precoz de cualquier patología periimplantaria, fase que se realizará durante las visitas de mantenimiento cuya periodicidad dependerá del grado de control por parte del profesional responsable del tratamiento de los factores de riesgo.

Hemos de tener en cuenta que la presencia de infección en los tejidos periimplantarios no implica que el implante fracase, entendiendo de forma absoluta por implante fracasado aquel que debemos retirar de la boca del paciente en que fue colocado.

La salud óptima alrededor de los implantes a largo plazo dependerá de la inhibición de la formación de la placa, prevención de su adhesión, eliminación de esta y control de la actividad de la enfermedad periodontal. Es por ello necesario un adecuado protocolo de reevaluación y mantenimiento, que deberá consistir en:

- Examinar y evaluar los tejidos periimplantarios.
- Radiografía periapical anual para monitorizar el nivel óseo.
- Instruir y motivar al paciente para que tenga una correcta higiene oral, para lo cual nos será muy útil el empleo de indicadores y reveladores de placa.
- Eliminación de los depósitos blandos y duros que se hayan formado alrededor de los implantes, prótesis o dientes remanentes. En el caso de los implantes deberemos emplear instrumental que por su composición y dureza no altere la biocompatibilidad de la capa de óxido de titanio ni ralle la superficie metálica de los diferentes elementos que forman la prótesis. Utilizaremos raspadores y curetas metálicas recubiertas de metales o aleaciones nobles, de plástico, de teflón y de cerámica. Las curetas de titanio, hoy por hoy, son los instrumentos más recomendados por la mayoría de los investigadores.
- Instrucciones de higiene oral. Las recomendaciones e instrucciones en higiene oral en implantes dadas a nuestros pacientes estarán determinadas por la localización y angulación de los implantes, longitud y posición de los elementos transmucosos, del diseño de la prótesis, así

como de los hábitos del paciente, motivación, destreza manual y estado de salud oral. Por lo tanto, las instrucciones de higiene oral deben adecuarse a las peculiaridades de cada paciente.

En general se recomienda el uso de cepillo dental blando/medio con pasta de dientes poco abrasiva y el empleo cuidadoso de métodos de higiene en zonas interproximales (cinta dental, cepillo interproximal, cepillo unipenacho).

Los colutorios de clorhexidina están indicados en casos de periimplantitis o mucositis periimplantaria o bien en tratamientos de choque ante pacientes con higiene muy defectuosa.

El empleo de cepillos eléctricos o sistemas de irrigación queda a la discreción del clínico.

El irrigador puede ser un dispositivo que, mal utilizado, impacte la suciedad hacia la encía.

Por ello, si lo recomendamos (por ejemplo, en prótesis híbridas) hemos de detenernos en enseñar bien la técnica al paciente y recomendar siempre que lo usen con la mínima presión.